

CC ORL – USIT 2

Anamnèse

- Motif principal, comorbidités, médicaments déjà pris
- Toujours demander si tabac, OH ou drogues

Examen clinique

Oreilles

Otoscope

- tjrs ddc, et toujours commencer par oreille saine
- N : reflet antéro-inf, transparent
- OMA : rouge, bombé, plus de reflet, mat, on peut voir niveau derrière
- Attention, si OE -> changer le spéculum pour pas disséminer l'infection

Acoumétrie

- Weber : latéralisé (du côté ou central)
- Rinne :
 - o Mettre le diapason sur mastoïde puis devant oreille (avec 2 branches parallèles donc en « axial »
 - o N = plus fort en aérien ; si plus fort en osseux -> pb transmission donc Rinne neg
- Voix chuchotée
 - o Boucher une oreille puis chuchoter de l'autre côté des chiffres
 - o Si arrive pas à percevoir la voix chuchotée -> voir s'il arrive à les percevoir avec la voix à volume N

Cavité buccale

- Lampe frontale et 2 abaisse-langues
- Commencer par les lèvres
- Puis joues, gencives, sillons inf et sup
- Bien regarder la langue, la base de la langue, le plancher et le sillon gingivo-glosse et les 2 côtés
- Regarder toujours l'état des dents et les percuter
- Puis fond de gorge : luette, amygdales, piliers ant et post et la paroi post du pharynx

Palpation cou

- Occipital, rétro-auriculaire
- Pré-auriculaire
- Groupe 1a (sous le menton), 1b (sous-mandibule)
- Puis on fait incliner la tête de côté et on cherche 2 (au-dessus os hyoïde) 3 (entre hyoïde et cricoïde) 4 (cricoïde à fourchette sternale) qui est le long du SCM (et dessous !!)
- Groupe 5 entre SCM et trapèze
- Puis sus-claviculaire
- Puis la même chose de l'autre côté

Nez

- Observation : on regarde si dévié, on regarde si collumelle est déviée (suspicion de septum dévié)
- Regarder ailes du nez : on regarde si collapsus des ailes lors du sniff test
- Attention avec le speculum, on l'ouvre que quand on est dedans et bien le regarder dans l'axe horizontal (pas le tourner vers le haut)
- Ne pas fermer le speculum en sortant (pas complètement sinon on va arracher les poils)

Vertiges

Anamnèse :

- Caractère
 - **Combien de temps ça dure**
 - Ménière : 20min à 12h, VPPB : qq sec
 - Tangage ou Carrousel sert à rien (discrimine R)
- Symptômes **neuro** (diplopie, céphalée, etc) et **FRCV**

Examen clinique :

- **HINTS (head impulse, nystagmus, skew deviation)**
- **Gaze nystagmus**
 - on demande au patient de fixer le doigt et on le bouge à 30 degrés (pas trop sinon nystagmus physiologique !) à droite et gauche et on regarde si nystagmus
 - Central : multidirectionnel ou change de direction
 - Frenzel (supprimer la fixation et mieux voir les yeux) : on demande au patient de regarder au milieu, à droite et à gauche et on regarde si amplifié sans fixation (suggestif de vestibulaire)
- **HIT**
 - Patient fixe notre nez et on tourne sa tête (pas besoin d'aller très loin mais il faut aller vite)
 - N : il arrivera à fixer nez
 - Si déficit vestibulaire brusque : saccade de reposition (c'est le cervelet qui va corriger la cible car vestibule marche pas)
 - HIT patho à G = déficit vestibulaire à G
- **Skew deviation**
 - On cache œil et on change
 - On cherche mouvements verticaux
- **Dix-Hallpike**
 - VPPB (un des plus fréquents) : canal post est le + touché
 - Si on test canal post D -> tête tourné un peu vers la gauche puis on fait tomber le patient sur son épaule droite
 - Latence de qq secondes puis nystagmus horizonto-rotatoire et vertiges ++
 - Dès que c'est fini -> on le remonte
 - On peut faire avec lunettes de Frenzel si on veut mieux voir

5 symptômes otologiques : Hypoacousie, Acouphène, Otorrhée, Ootalgie/Plénitude, Vertiges